MINUTA DE ALCANCE · PRIMERA ETAPA

Clínicas Enlace México

Registro único de pacientes, agenda de citas y recepción

Estimada Laura: esta minuta resume lo que acordamos en nuestras conversaciones de Slack sobre la primera etapa del sistema. Le pedimos revisarla y confirmarnos si está de acuerdo con el alcance, o indicarnos sus observaciones.

Campo	Contenido
Proyecto	Clínicas Enlace México: registro único de pacientes, agenda de citas y recepción
Fecha	02/11/2026
Participantes	Laura Méndez (cliente); Xóchitl, Ivri, Itzel e Israel (equipo de desarrollo)
Medio	Slack

Lo que se desarrollará en la primera etapa

1. Acceso con usuario y contraseña; cada persona ve solo lo que corresponde a su puesto y a su clínica.
2. Registro único de pacientes para las tres clínicas, con un número de identificación generado por el sistema.
3. Aviso de posibles pacientes duplicados, por CURP o por nombre y fecha de nacimiento, para que recepción lo revise.
4. Agenda por clínica: crear, cambiar y cancelar citas, sin que se encimen y dentro del horario de cada profesional.
5. Historial de cada cambio en una cita: qué cambió, quién lo hizo y por qué.
6. Recepción registra la llegada del paciente; el personal médico marca cuándo inicia y termina la atención.
7. Reportes de citas por clínica y un reporte general de la red para coordinación nacional.

Lo que no incluye esta etapa

Función	Cuándo se verá
Solicitudes y resultados de laboratorio	Segunda etapa
Cargos, pagos y saldos	Tercera etapa
Cuentas o citas en línea para pacientes	Sin fecha definida
Dirección completa del paciente	Sin fecha definida
Expediente clínico o notas médicas	No forma parte del proyecto
Unión automática de registros de pacientes	No se hará, según lo que usted indicó
Más de tres clínicas	Más adelante; el sistema queda preparado para crecer

Prioridades

Prioridad	Funciones
Alta	Acceso por puesto y clínica; registro de pacientes y aviso de duplicados; agenda sin citas encimadas; historial de cambios; llegada y atención
Media	Actualización de datos del paciente; marcar «no asistió»; reportes

Decisiones acordadas

1. Se empieza con registro de pacientes, citas y recepción; después se incorporan laboratorio y cobros.
2. El sistema asigna a cada paciente un número único que sirve en las tres clínicas.
3. Datos obligatorios del paciente: nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono. CURP y correo son opcionales.
4. Los posibles duplicados solo se avisan; recepción decide si es la misma persona.
5. Tipos de cita: consulta de primera vez y de seguimiento. Estados: programada, llegó, en atención, finalizada, cancelada y no asistió.
6. Coordinación nacional consulta reportes, pero no modifica las agendas de las clínicas.
7. Le mostraremos avances cada dos semanas para que los revise.
8. En pruebas y demostraciones solo se usan datos ficticios.

Preguntas que necesitamos que nos responda

#	Pregunta	Para qué la necesitamos
1	¿Cuáles son los horarios de atención y cuánto dura cada tipo de consulta?	Para que solo se puedan dar citas dentro del horario de cada profesional
2	¿Cómo se llaman y en qué estado están las tres clínicas iniciales?	Para configurar las clínicas en el sistema
3	Cuando recepción confirma que un paciente ya estaba registrado, ¿solo usa el registro existente? ¿Alguien puede unir registros que ya se duplicaron?	Para definir cómo se resuelven los duplicados
4	¿Qué zona horaria usa cada clínica?	Para que las horas de las citas y reportes sean correctas
5	¿Cuánto tiempo de tolerancia hay antes de marcar que un paciente no asistió?	Para marcar correctamente las inasistencias
6	¿Qué datos le gustaría ver en los reportes de cada clínica y de la red?	Para diseñar los reportes
7	¿Un profesional puede atender en más de una clínica?	Para controlar su disponibilidad y que no se encimen sus citas
8	¿Quién dará de alta a los usuarios y profesionales del sistema?	Para definir quién administra las cuentas
9	¿La recepción de una clínica puede corregir los datos de un paciente registrado en otra?	Para definir quién puede actualizar los datos compartidos

Propuestas del equipo para confirmar

Si no nos indica lo contrario, trabajaremos con estas propuestas:

#	Propuesta
1	El sistema no se conectará con otros sistemas que ya usen las clínicas
2	Será una aplicación web, usada desde el navegador de una computadora con internet
3	La administración de cada clínica registra los horarios de sus profesionales
4	Cada usuario pertenece a una sola clínica, excepto coordinación nacional
5	Consideraremos exitosa la etapa si los duplicados se detectan a tiempo y no hay citas encimadas
6	La observación administrativa de cada cita tendrá máximo 200 caracteres
7	Durante la prueba piloto, nuestro equipo creará las cuentas de usuario
8	Solo se pueden cancelar o cambiar citas que aún estén programadas, no las que ya iniciaron o terminaron

Consecuencias que le pedimos considerar

Usted nos pidió que le explicáramos lo que se complica o depende de otra cosa. Antes de aceptar, le compartimos las consecuencias de algunas decisiones que podrían pasar desapercibidas:

Decisión	Consecuencia	Lo que proponemos
Tener todo conectado: citas, laboratorio y cobros	Laboratorio y cobros dependen de las citas y los permisos. Hacerlos al mismo tiempo multiplica los errores y retrasa la agenda, que es lo más urgente.	Avanzar por etapas: primero pacientes, citas y recepción; luego laboratorio; al final cobros.
Compartir datos de pacientes entre las tres clínicas	Más personas tendrán acceso a datos de salud. La ley mexicana de protección de datos personales los considera datos sensibles, y una filtración afectaría a pacientes de toda la red.	Compartir solo identificación y contacto, y que la red defina su aviso de privacidad antes de usar datos reales.
Detectar pacientes duplicados	Unir por error a dos personas mezcla sus datos. Hay muchos nombres repetidos, y sin CURP la detección es menos confiable.	No unir registros automáticamente, como usted pidió, y solicitar la CURP siempre que el paciente la tenga.
Clínicas en varios estados	México tiene varias zonas horarias. Si el sistema usa una sola hora, una cita podría quedar registrada una hora antes o después.	Registrar la zona horaria de cada clínica y mostrar siempre la hora local.
Horarios y duraciones por confirmar	Sin esos datos, el sistema no puede impedir citas encimadas ni fuera de horario, que es lo principal de la agenda.	Que nos los comparta lo antes posible; mientras tanto, los dejaremos ajustables.
Reportes para coordinación nacional	Un reporte con datos de cada paciente le daría a coordinación acceso a información que usted no quiere abrir.	Reportes con totales y porcentajes, sin datos clínicos de pacientes.
Corregir datos de pacientes desde cualquier clínica	Como el registro es compartido, un error de captura en una sede cambia el dato en toda la red.	Guardar el historial de cambios y acordar quién puede corregir datos de otra clínica.

Decisión	Consecuencia	Lo que proponemos
Pacientes sin cuenta en el sistema	Sin recordatorios ni confirmación del paciente, es probable que haya más inasistencias.	Medir las inasistencias desde esta etapa para decidir después si conviene agregar recordatorios.

Aceptación

> Para aceptar esta minuta, le pedimos responder en Slack con la frase **«Acepto el alcance de la primera etapa»**, o enviarnos sus observaciones y respuestas a las preguntas anteriores.

Nombre	Papel	Fecha	Resultado
Laura Méndez	Cliente		
Xóchitl	Líder del equipo	02/11/2026	Compromiso del equipo